



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عزيزه محمد محمود عبد الرؤف

العنوان : ممم

الحى / المدينة : العجوزه

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستماره : 19-09-2026

رقم البطاقه : 28108052100365 رقم التليفون : 01115920304

العمر (تاريخ الميلاد) : 05-08-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدته 6 شهور

قسم العلاج :
الاورام

[14163]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

قسم :

جهة العلاج :

نفقات :

ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عزيزه محمد محمود عبد الرؤف National ID: 28108052100365	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

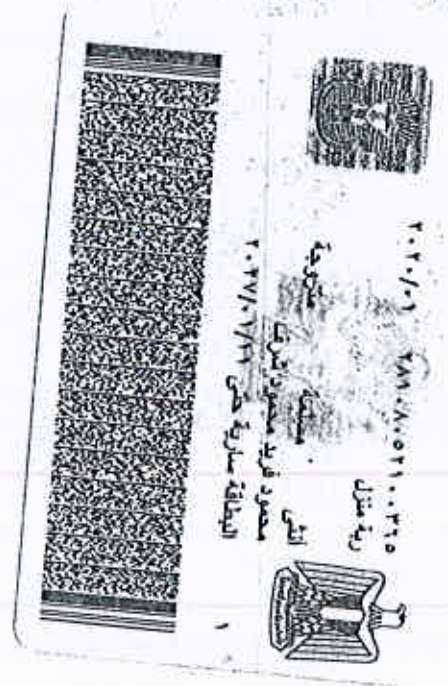
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name : الأستاذة / عزيزة محمد محمود عبدالرؤف	Request No. : 139254
Patient No. : 28108052100365	Request Date : 28/11/2021
Path No. : SR-681/21	Verification Date : 30/11/2021
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 40 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer.

Nature of the specimen:

Slide revision.

Gross Examination:

One paraffin block labeled as (865-21) and three slides were received.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II
- Examination of ER stained slide show moderate nuclear staining in 20% of the tumor cells.
- Examination of PR stained slide show moderate nuclear staining in 60% of the tumor cells.
- Examination of HER2 stained slide show intense staining in >10% of tumor cells with complete membranous staining.

Diagnosis:

Right breast cancer; slide revision:

- Invasive duct carcinoma, nuclear grade II

• Biomarkers:

- o ER: Positive (Allred score 4/8)
- o PR: Positive (Allred score 7/8)
- o Her2: Positive (score 3+)

Prof. Dr. Aml Hareedy

Dr. Walaa Ghonaim



Patient Name	: الأستاذة / عزيزة محمد محمود عبدالرؤف	Request No.	: 13002329
Patient No.	: 28108052100365	Request Date	: 10/05/2022
Path No.	: 1211/2022	Verification Date	: 21/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Rt breast cancer, Post neo-adjuvant chemotherapy

Nature of the specimen: MRM

Gross Examination:

- Procedure: MRM measured 21x19x5cm, skin ellipse measured 24x14cm
- Localization: Rt
- Tumor bed site extent
 - o Number: an ill-defined greyish white rubbery
 - o Size: 3x2x2 cm
 - o Skin involvement: Grossly unremarkable
- Distance from margins: 2.5cm from deep margin
- Lymph nodes number and size: 16 nodules up to 1cm

Microscopic examination:

- No residual tumour cells
 - o Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free (0/16) LNs
- Resection Margins:
 - o Free deep margin
- Histologic response to therapy: Pathological complete response

Diagnosis:

Rt breast cancer, MRM:

- No residual tumour cells
 - o Free nipple and areola
- Free (0/16) LNs
 - o Free deep margin
- Pathological complete response

Verified by :

dr.menna atef

Patient Name	: الأستاذة / عزيزة محمد محمود عبدالرؤف	Request No.	: 13002329
Patient No.	: 28108052100365	Request Date	: 10/05/2022
Path No.	: 1211/2022	Verification Date	: 21/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

• Stage: ypT0, ypNo

Prof. Lubna Omar
Dr. Menna Atef

Verified by :
dr.menna atef

Printing Date : 24/05/2022 11:45:44

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH TRIPHASIC STUDY OF THE LIVER REVEALED:

- Right breast inner quadrant irregular shaped heterogeneously enhancing mass lesion measuring about 35x63mm along its maximal axial planes.
- Few enlarged right axillary (Level I & II) lymph nodes, the largest measures about 14x25mm.
- Bilateral few scattered millimetric nodules are noted.
- No pulmonary masses, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No sizable enlarged hilar or other mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No gross cardiac abnormalities.
- Normal appearance of the chest wall.

- The liver is mildly enlarged showing homogenous CT density with no hepatic focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Radiodense gastric stipple of bariatric surgery is noted.
- Normal CT appearance of the spleen, both kidneys, pancreas, supra renal glands, aorta & IVC.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Anteverted bulky uterus with large central hypodense lesion for ultrasound correlation.
- No adnexal solid or cystic mass lesions.
- No abdominal or pelvic collections.

- No osseus lytic or sclerotic deposits.

OPINION:

- Right breast inner quadrant neoplastic mass lesion with ipsilateral few axillary lymphadenopathy.
- Bilateral few pulmonary millimetric nodules for follow up.
- No CT evidence of hepatic or osseus deposits.

Reported By,

Dr. Salwa Yahya , MSc
Dr. Mahmoud Saleh, MD

07-Nov-2021 02:44 PM



MDT FORM

١١٢٨٦٦٤١١٦

2022/6/2

Name	عائزة محمد محمود	MRN	C.C.I / 0.18
Age	40 y	ID	C.N.I.A.0.C.I.570
Menopausal status		Phone	
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	IDC cell.			R	Rt mRM	L
ER:	418	PR:	718	HER 2:	3 ⁺	Ki67:
Sonomammography:	Rt mRM					
Mets Workup:	Free nipple & axilla Free LN 0/16			T N M cT4 - N2 (lumel) → TCHP X 6 cycles		
Recommendations:	Free deep margin pathological complete response → mRM. 4P To, 4P No					

MDT OUTCOME & PLAN

PCR

To continue Herceptin + pegfilgrastim 17 cycles

- PORT

- AI + zolodex 15y

+ pegfilgrastim 16m	SIGNATURE		
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
Mulla			